

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE RELACIÓN DE AYUDA

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TENS	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Relación de Ayuda
CURSO		N° ACTIVIDAD	1
ASIGNATURA	CES4111	DURACIÓN	120 minutos (3 módulos)
FECHA		N° DE ALUMNOS	12 alumnos
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA			
1. Ejecutar intervención de relación de ayuda en usuario con dificultades de salud mental en contexto de atención primaria en salud. 2. Demostrar herramientas comunicacionales de la relación de ayuda en usuario con dificultades de salud mental en contexto de atención primaria en salud.			

3: INTRODUCCIÓN

La relación de ayuda es un componente esencial del cuidado humanizado y profesional. Esta competencia comunicacional permite al personal técnico de enfermería establecer vínculos terapéuticos efectivos con los pacientes, promoviendo su bienestar emocional, contención, adherencia a tratamientos y mejor recuperación. En un entorno clínico, la capacidad de escuchar activamente, empatizar y responder de manera adecuada a las necesidades emocionales y psicológicas de los usuarios es tan relevante como el manejo de procedimientos técnicos.

En Chile, la salud mental y el bienestar emocional de la población han adquirido una creciente relevancia en los últimos años. Según datos recientes del **Ministerio de Salud y la Encuesta Nacional de Salud (ENS 2023)**, más del **21% de los adultos reporta síntomas asociados a trastornos de ansiedad o depresión**, mientras que la **sobrecarga del sistema de atención primaria limita el tiempo disponible para intervenciones de contención emocional**. A esto se suma el impacto de crisis sociales y económicas, que han incrementado la prevalencia de síntomas de estrés, ansiedad y desesperanza, especialmente en adolescentes, adultos mayores y trabajadores de la salud.

El **impacto en la salud pública chilena es significativo**: los trastornos de salud mental representan una de las principales causas de años perdidos por discapacidad, y el aumento sostenido en la demanda por atención psicológica evidencia la necesidad de fortalecer las competencias comunicacionales en todos los niveles del equipo de salud, incluidos los técnicos en enfermería.

4: DESARROLLO DEL TEMA

La relación de ayuda: modelo de persona a persona de Joyce Travelbee

Definición: La relación de ayuda es: *“Un proceso interpersonal mediante el cual se ayuda a una persona, familia o comunidad con el objetivo de promover la salud mental, prevenir o afrontar la experiencia de la enfermedad y el sufrimiento mental y si es necesario contribuir a descubrir un sentido en esas experiencias”* (Travelbee, 1979).

La relación de ayuda se refiere a un proceso interpersonal en la medida en que, tanto paciente como agente de salud, dan significado a sus experiencias durante el proceso, para que esto se

cumpla, es necesario saber que en el proceso ambos aprenden del otro y se contribuye a la salud mental.

El objetivo de la relación de ayuda es **acompañar** en el proceso de sufrimiento y superarlo, para darle sentido a la experiencia; así también, acompañar en el proceso de toma de conciencia de los problemas y las fortalezas de la persona y mostrar conductas de vida saludables. Por lo tanto, es muy importante señalar que el técnico nivel superior de enfermería (TSEN) debe tener especial cuidado en las expectativas que se tienen al ayudar a un paciente, ya que resulta fácil frustrarse si el paciente no responde como esperamos. La respuesta está en tener en mente el concepto de acompañar al paciente. ***Está demostrado que el simple hecho de acompañar en el sufrimiento es suficientemente terapéutico, sin necesidad de hacer profundas intervenciones.***

Características:

1. Es una relación planificada, deliberada y consciente entre una persona que necesita ayuda y otra que está capacitada para otorgarla.
2. Es un proceso que evoluciona en etapas o fases dinámicas, o sea, que no van ordenadas. Estas etapas son:
 - a) **Fase previa a la interacción:** es donde el profesional reconoce sus propios sentimientos, emociones, miedos, expectativas y se consideran los objetivos a conseguir con el paciente.
 - b) **Fase de orientación:** es donde se exploran los hechos que traen al paciente a consultar.
 - c) **Fase de identidades emergentes:** se identifican claramente los problemas, por lo que se le ayuda a leer con mayor finura los eventos, se determina cuánto puede hacer la persona para solucionar su problema, se identifican personas que la puedan apoyar, se analizan soluciones alternativas al problema. Lo central en la interacción, más allá de solucionar un problema o no, es que el paciente sienta la experiencia de haber sido **acogido, escuchado y aceptado**.
 - d) **Fase de término:** cerrar el proceso y hacer un resumen con lo conversado, se debe ser claro en el cierre del proceso para evitar dependencias.
- 3.- **Es un proceso que provoca cambios en ambos actores de la relación:** el ayudado recibe la experiencia antes mencionada y el que ayuda aumenta su capacidad de comprometerse en relaciones de ayuda, observar su propia conducta y sus experiencias. Aprende de las experiencias del otro, a escuchar y a confiar en la vida del otro.

Supuestos para la relación de ayuda

Son necesarias tres disposiciones de la persona que ayuda para fomentar la relación terapéutica:

1. **Compromiso emocional:** es la capacidad de interesarse por otra persona sin que ese interés nos inhabilite para ayudarlo. No ocurre con todos los pacientes y no es necesario obligarse a hacerlo. Es importante el autoconocimiento. No comprometerse emocionalmente es un peligro ya que caemos en la desconexión emocional con los pacientes.

2. **Aceptación y actitud no juzgadora:** para aceptar a un paciente se debe tener conciencia de las situaciones que nos provocan rabia, resentimiento y molestia, y entender que nuestra intervención tiene el objetivo de aliviar el sufrimiento del paciente. Además, es recomendable enjuiciar la situación en sí misma, no al paciente.
3. **Objetividad:** es la capacidad de observar lo que realmente ocurre excluyendo prejuicios derivados de los sentimientos personales.

Objetivos de la relación de ayuda

1. Ayudar a la persona a enfrentarse con los problemas presentes. No buscar causas del pasado.
2. Ayudar a la persona a conceptualizar sus problemas: delimitarlos y enfocarse, identificando cómo afecta ese problema a la persona.
3. Ayudar a la persona a percibir su participación en sus experiencias: la persona no es una víctima de la situación, es parte activa del problema y de la solución.
4. Ayudar a la persona a enfrentar en forma realista los problemas emergentes, ocuparse de los problemas, no de suposiciones.
5. Ayudar a la persona a buscar soluciones alternativas.
6. Ayudar a la persona a ensayar nuevas formas de comportamiento: una cosa es encontrar una solución y otra distinta es encontrar la forma práctica de enfrentarlo.
7. Ayudar a la persona a comunicarse: que exprese sus problemas, emociones, lo que piensa.
8. Ayudar a la persona a socializar.
9. Ayudar a la persona a encontrar un sentido a lo que vive: el ¿por qué? Ocurren las cosas.



Técnicas en la relación de ayuda

- 1.- **Verbalización:** que la persona hable sus problemas. Por sí misma es una técnica que libera tensión y angustia. Es necesario que la persona diga todo lo que le pasa y en este punto es muy importante que quien ofrece la ayuda sea capaz de controlar la emisión de juicios o prejuicios. Se debe estimular a la persona a hablar haciéndole preguntas cortas y de carácter abierto, por ejemplo ¿qué sucedió en ese momento?; cuénteme ¿qué sintió cuando ocurrió eso?; ¿qué significa para Ud. “me dio lata”?
- 2.- **Aclaración:** se utiliza cuando el entrevistador no comprende una situación y es importante aclararla inmediatamente antes de continuar, al hacer esto el paciente tiene la sensación de que la persona está poniendo atención y tiene el deseo de entenderlo. Además, es útil para que el

mismo paciente se aclare en lo que está contando, ya que a veces, en períodos de angustia, las personas podemos hablar de manera confusa. Por lo tanto, al aclarar no sólo el entrevistador puede comprender mejor el problema sino también el paciente. Por ejemplo: ¿a qué se refiere con...?; no logro entender lo que me quiere decir ¿podría explicármelo nuevamente?

3.- **Enfocar:** muchas veces los pacientes en contextos de angustia y crisis confunden los temas y los superponen al verbalizarlos, este fenómeno se denomina disgregación: saltan de un tema a otro. Es importante enfocar al paciente para darle sentido a la comunicación. Se hace necesario interrumpir al paciente e indagar en la razón de su disgregación y ordenarlo.

4.- **Ayudar a identificar causa-efecto en su conducta:** esto se logra posicionando la participación del paciente en términos temporo-espaciales en su relato. Por ejemplo: ¿qué hizo Ud. antes que su pololo le dijera que no quería seguir la relación?; ¿qué hizo Ud. durante la conversación?; ¿qué hizo Ud. después que terminaran de hablar? De esta manera el paciente logra ver cómo su conducta impactó o impacta en el desarrollo de su problema.

5.- **Escucha activa:** es una de las capacidades más importantes en una relación de ayuda y, así mismo, es difícil de desarrollar ya que exige un amplio autoconocimiento y una constante observación de uno mismo al mismo tiempo que se interviene en el paciente. Es un “*darse cuenta*” de lo que hago y cómo lo hago. Se materializa en la postura corporal hacia el paciente, contacto ocular, escuchar lo que el paciente dice sin poner nuestra opinión enfrente, seguir la conversación con frases y expresiones como: “continúe...” “mmm”, asentir con la cabeza, acercarse al paciente, inclinarse levemente hacia el paciente, dar a conocer al paciente que lo entiende. Cuando la persona se siente escuchada se siente tomada en serio, siente que puede confiar, se abre y se desahoga, y con ello disminuye mucho su angustia o ansiedad.

6.- **Ayudar a la persona a percibir su participación en la experiencia:** es importante introducir al paciente en la experiencia que nos está contando.

Al finalizar la entrevista se debe cerrar el proceso con el paciente; es aceptable realizar un resumen con los temas acordados y/o despedirse. Es clave dejar de manifiesto que la interacción ha terminado y no compartir datos para verse en el futuro ya que esto favorecería una relación dependiente.

Pauta de cotejo (Coevaluación entre pares)

Criterio a Evaluar	Si (✓)	No (X)
1. Se presenta de manera respetuosa con nombre y cargo al paciente		
2. Identifica correctamente al paciente por su nombre.		
3. Escucha activamente al paciente, manteniendo contacto visual y atención plena.		
4. Identifica expresiones verbales del paciente que indican malestar, duda o necesidad.		
5. Reconoce señales no verbales (tono de voz, gestos, postura) que sugieren necesidad de ayuda.		
6. Pregunta de manera oportuna y pertinente para profundizar en la situación del paciente.		
7. Reformula o parafrasea lo dicho por el paciente para confirmar su comprensión.		
8. Muestra empatía y contención emocional frente a manifestaciones del paciente.		
9. Propone o inicia acciones de apoyo en respuesta a la necesidad detectada.		
10. Documenta o comunica adecuadamente la necesidad identificada al equipo de salud.		
11. Se expresa de forma clara, tranquila y sin interrupciones innecesarias.		

6: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Fernández Lucio C., Delgado Bolívar DR., Hernández Olivera D. Estrategias comunicativas para la relación de ayuda en la enfermería. *Revista Cubana de Enfermería* [Internet]. 2020. Disponible en: <https://revistaenfermeria.sld.cu/index.php/enf/article/view/3325>
- RIVERA, M.S. Teoría de la relación persona-persona de Joyce Travelbee como sustento de la enseñanza de la Enfermería. *Horizonte de enfermería*. 14. 2003. 95-111.